

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	雙腔導管護理 Nursing Care of Double lumen Drainage				
編號	A31000-Q02-W-C16	制定者	HD 黃佳玲	公布日期	99 年 04 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	111 年 07 月 05 日
版本/總頁數	第 3.6 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 06 月 05 日

一、目的

提供雙腔導管放置及固定之正確性，確保病人安全。

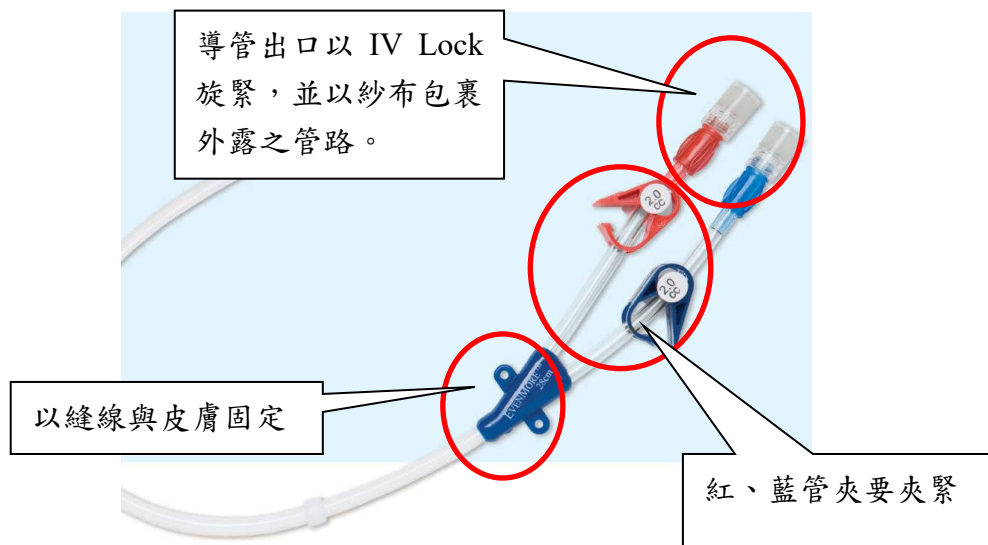
二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）當病人的腎臟無法排泄體內多餘的水份及廢物，而需進行血液透析治療時，但又無永久性之血管通路，所以要放置暫時性血管通路以利進行血液透析治療。暫時性血管通路放置的位置有頸靜脈、鎖骨下靜脈、股靜脈，依據放置的位置其固定方式如下

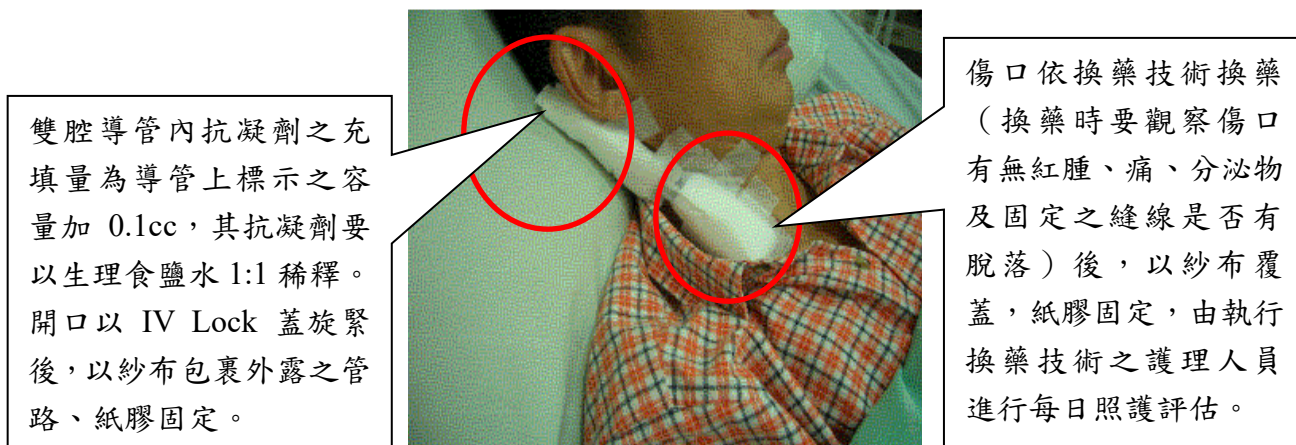
1. 雙腔導管之簡介（圖一）。



圖一

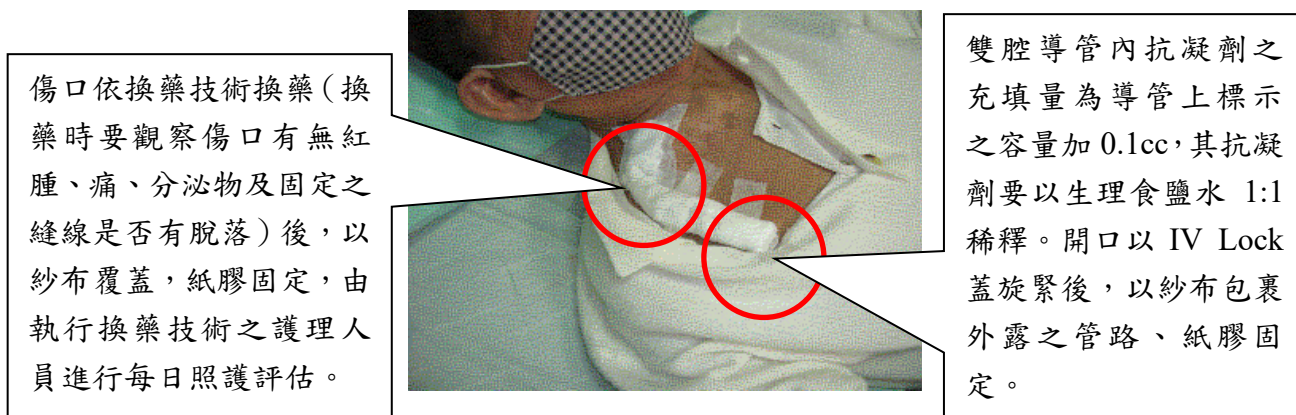
主題名稱	雙腔導管護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C16	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/6

2. 頸靜脈雙腔導管固定方式（圖二）。



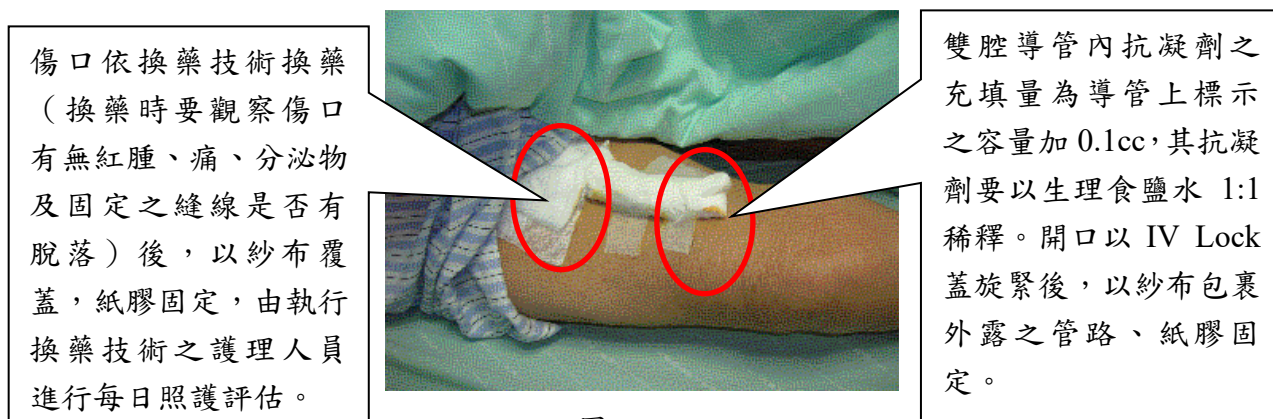
圖二

3. 鎖骨下靜脈雙腔導管固定方式（圖三）。



圖三

4. 股靜脈雙腔導管固定方式（圖四）。



圖四

主題名稱	雙腔導管護理	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q02-W-C16	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/6

(二) Daugirdas, J. T., Blake, P. G., & Ing, T. S.(2015)提到導管的封存方式為每次透析後，各導管的管腔不活動區，應經由導管注射口，用肝素(1000-5000 IU/mL)填滿，以預防導管之凝固。血液透析室依此為依據，規範導管內抗凝劑（肝素）要以生理食鹽水 1:1 稀釋，稀釋後之肝素為 2500 IU/mL，其充填量為導管上標示之容量加 0.1cc。舉例：以 3mL 空針抽抗凝劑（肝素）1mL+生理食鹽水 1mL 後，若導管上標示 1.6mL，則要填充 1.7mL 的稀釋溶液。

(三) 異常狀況處理說明

異常狀況	處理對策
錯置：導管置入位置不正確，經由 CXR 確認其位置。	1. 拔除導管加壓止血，重新置入雙腔導管。 2. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
縫線脫落	1. 告知醫師，請醫師判定導管位置是否正確，若正確則以縫線重新縫好固定，並以紗布覆蓋，紙膠固定；若不正確則予以拔除導管，加壓止血後，再重新插管。 2. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
感染	1. 透析治療前觀察傷口是否有發炎（紅腫、分泌物）及縫線是否有脫落之情形，若無發炎及縫線脫落則予以傷口換藥；若有發炎情形則告知醫師，依醫囑執行處置；若有縫線脫落，則依縫線脫落對策處理；觀察病人是否有感染之情形。
IV Lock 蓋子脫落	1. 告知醫師，依醫囑處置，因雙腔導管已染污，故拔除導管加壓止血後，再重新插管，並觀察病人是否有感染之情形。 2. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
雙腔導管破裂	1. 告知醫師，拔除導管加壓止血，由醫師評估是否重新置入雙腔導管。 2. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
雙腔導管滑出	1. 加壓止血，並觀察病人是否有感染之情形，由醫師評估是否重新置入雙腔導管。 2. 於 HIS 系統完成異常事件通報。
導管穿刺位置血腫	1. 告知醫師，依醫囑處置照 X-ray，若因穿刺血管破裂引起之嚴重血腫或無法止血，則要拔除導管並觀察病人之呼吸型態，若有呼吸困難之情形，則要緊急插管

主題名稱	雙腔導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C16	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/6

異常狀況	處理對策
	維持正常的血氧量；若血腫處已無出血且沒影響呼吸功能則予以冰敷並持續觀察病人之生命徵象。

(四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) Daugirdas, J. T., Blake, P. G., & Ing, T. S.(2015)・透析手冊（陳忠棋、陳冠樺、陳冠融、施維怡譯；5 版）・力大。(原著出版於 2015)

七、附件

(略)

主題名稱	雙腔導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C16	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.04.20	1.0	新制定。	99 年 04 月 20 日 護理部照護標準 委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.04.06	2.1	修改說明內容。	100 年 04 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
101.06.06	2.2	修改範圍及說明內容。	100 年 06 月 06 日 護理部照護標準 委員會通過。
102.02.26	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.06.02	3.1	第三項第（二）目異常狀況處理說明刪除：填寫管路自拔／滑脫意外事件報表及病安通報、填寫異常處置表及病安通報；改為~於 HIS 系統完成異常事件通報。	104 年 06 月 02 日 護理部照護標準 委員會通過。
105.06.07	3.2	第三項第（一）目之圖三及圖四說明增加：由執行換藥技術之護理人員進行每日照護評估。	105 年 06 月 07 日 護理部照護標準 委員會通過。
106.06.05	3.3	第三項說明內容增修標點符號。	106 年 06 月 05 日 護理部照護標準 委員會通過。
107.06.13	3.4	第三項第一目之圖二說明增加：由執行換藥技術之護理人員進行每日照護評估；圖二、圖三及圖四依據現行臨床執行上做增修。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過。
108.06.06	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 1. 第三項第一目、第二目，文辭修訂。 2. 第三項第一目之圖一原為參腔導管予更換為雙腔導管。 3. 第三項第一目之圖一、圖二、圖三、圖四增修文字，以紗布包裹外露之管路。 4. 第三項第三日本辦法經委員會通過後公布實	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過；108 年 06 月 12 日護理長會 議通過；108 年 06 月 18 日督導會議 通過公布。

主題名稱	雙腔導管護理	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q02-W-C16	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
		施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	
109.06.04	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.07.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.07.05	3.6	第三項說明內容新增導管的封存方式。 第六項新增參考文獻。	111 年 06 月 02 日照護標準組會議通過；111 年 06 月 08 日護理長會議通過；111 年 07 月 05 日督導會議通過公布。
112.06.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.06.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	